Conteo de hidratos de carbono (HC)

Etiquetas, raciones, ratios y ejemplos de cálculo.

70 preguntas · Una única respuesta por pregunta. Aprobado: 49 aciertos o más (al menos el 70 %).

Marca una opción. Cada acierto suma 1 punto; las respuestas incorrectas y sin responder no suman ni restan. El porcentaje se calcula sobre el total de preguntas.

Los ejemplos de insulina son educativos: no sustituyen la pauta individual. En este checklist, 1 ración = 10 g de hidratos de carbono (HC). La plantilla de respuestas está al final, para uso del profesional.

1. ¿Cuál es uno de los beneficios del conteo de carbohidratos ?

☐ A. Permite más flexibilidad en las comidas.
☐ B. Permite una dieta fija.
☐ C. Elimina la necesidad de insulina.
☐ D. Reduce la cantidad de alimentos consumidos.

2. En un alimento envasado, ¿qué información es especialmente útil para contar sus hidratos de carbono?

☐ A. Solo la publicidad del envase.
☐ B. La etiqueta nutricional, teniendo en cuenta la cantidad que vas a comer.
☐ C. Solo el color del paquete.
☐ D. Solo las calorías.

3. ¿Qué herramientas pueden ayudarte a aprender a estimar las cantidades de alimentos?

☐ A. Tablas o etiquetas con información de hidratos.
☐ B. Una báscula de cocina.
☐ C. Medidas caseras previamente comprobadas, como tazas.
☐ D. Todas las anteriores.

4. ¿Qué herramienta permite medir con precisión el peso de la porción de alimento?

☐ A. Contar las piezas sin considerar su tamaño.
☐ B. Mirar solo el precio.
☐ C. Una báscula de cocina.
☐ D. Estimar siempre a ojo.

5. ¿Por qué se sugiere crear una base de datos personal para el conteo de carbohidratos?

☐ A. Para reducir el costo de alimentos.
☐ B. Para hacer dieta.
☐ C. Para evitar la compra de alimentos innecesarios.
☐ D. Para tener un registro de alimentos similares consumidos frecuentemente.

6. ¿Cuál es el enfoque principal del conteo de carbohidratos?

☐ A. Limitar azúcares y calorías.
☐ B. Contar carbohidratos.
☐ C. Usar un sistema de alimentos equivalentes.
☐ D. Reducir la ingesta de alimentos.

7. ¿Qué aspecto del conteo de carbohidratos puede llevar a hiperglucemia?

☐ A. La falta de práctica.
☐ B. La necesidad de consumir menos azúcares.
☐ C. Usar fórmulas complejas.
☐ D. Conteo de carbohidratos poco preciso.

8. Si se calcula la insulina de una comida según sus HC, ¿qué error puede empeorar la glucosa después de comer?

☐ A. Comprobar la etiqueta.
☐ B. Pesar la porción cuando sea necesario.
☐ C. Contar incorrectamente los hidratos y calcular una dosis que no corresponde a la comida.
☐ D. Pedir ayuda al equipo si hay dudas.

9. En el conteo de carbohidratos, ¿Qué se debe tomar en cuenta al leer etiquetas?

☐ A. El contenido de azúcares solamente.
☐ B. Los ingredientes presentados.
☐ C. La cantidad total de carbohidratos.
☐ D. El precio del producto.

10. ¿Qué relación existe entre el conteo de carbohidratos y la hipoglucemia?

☐ A. El conteo de carbohidratos es irrelevante para la hipoglucemia.
☐ B. El conteo de carbohidratos impreciso puede causar hipoglucemia.
☐ C. La hipoglucemia no guarda relación en el conteo de carbohidratos
☐ D. No hay relación entre los dos

11. ¿Qué se debe tener en cuenta al practicar el conteo de carbohidratos en casa?

☐ A. Solo practicar con alimentos empaquetados.
☐ B. Usar diferentes artículos de la casa para entrenar la estimación de porciones.
☐ C. Enfocarse en teorías y métodos complejos.
☐ D. No es necesario practicar en casa.

12. ¿Cómo puede ayudar un conteo de HC más preciso al control de la diabetes?

☐ A. No tiene ninguna utilidad.
☐ B. Elimina la necesidad de controles de glucosa.
☐ C. Puede mejorar el ajuste de la insulina y el control de la HbA1c, junto con el resto del tratamiento.
☐ D. Garantiza una HbA1c perfecta sin seguimiento.

13. ¿Cómo se llama el conteo que utiliza una relación insulina/HC para calcular la insulina de la comida?

☐ A. Conteo sin considerar la insulina.
☐ B. Dieta sin hidratos de carbono.
☐ C. Conteo de calorías solamente.
☐ D. Conteo avanzado de hidratos de carbono.

14. En un ejemplo teórico, si 1 unidad cubre 20 g de HC, ¿cuántas unidades cubrirían 40 g, sin añadir corrección?

☐ A. 1 unidad
☐ B. 3 unidades
☐ C. 2 unidades
☐ D. 4 unidades

15. En el sistema de raciones de 10 g utilizado en este checklist, ¿cuántos gramos de HC contiene una ración?

☐ A. 5 gramos
☐ B. 10 gramos
☐ C. 15 gramos
☐ D. 20 gramos

16. ¿Qué información se encuentra en las etiquetas nutricionales?

☐ A. Solo la cantidad de azúcares
☐ B. La cantidad de carbohidratos en gramos
☐ C. La cantidad de proteínas y grasas, pero no carbohidratos
☐ D. Instrucciones de uso

17. ¿Qué se debe hacer si un paquete de pasta indica que contiene 35 gramos de carbohidratos por cada 100 gramos?

☐ A. Consumir todo el paquete
☐ B. Ignorar la etiqueta
☐ C. Calcular la cantidad proporcional dependiendo de lo que se consuma
☐ D. Únicamente consumir raciones

18. En un ejemplo, 2 unidades de insulina cubren 20 g de HC. ¿Qué relación representa?

☐ A. 1:5
☐ B. 1:15
☐ C. 1:10
☐ D. 1:20

19. ¿Qué es una ración en el contexto de carbohidratos?

☐ A. Una cantidad de carbohidratos estandarizada
☐ B. Una medida de calorías
☐ C. Una recomendación de actividad física
☐ D. Un tipo de alimento.

20. Para calcular la insulina que cubre los HC de una comida, ¿qué dato necesitas además de los gramos de HC?

☐ A. La relación insulina/HC pautada para ese momento.
☐ B. Solo las calorías del día.
☐ C. Solo el número de pasos.
☐ D. Solo las horas de sueño.

21. En un cálculo de insulina para una comida, ¿qué revisión es más completa?

☐ A. Considerar solo el agua bebida.
☐ B. Revisar HC, glucosa, insulina activa y actividad prevista según el plan individual.
☐ C. Considerar únicamente la hora del reloj.
☐ D. Ignorar las dosis previas.

22. ¿Qué permite al usuario del contaje avanzado tener flexibilidad en la comida?

☐ A. El tiempo de las comidas
☐ B. La cantidad de calorías
☐ C. El tipo de carbohidratos
☐ D. La relación insulina/carbohidratos

23. ¿Qué representa una relación insulina/carbohidratos de 1:10?

☐ A. Diez unidades por cada gramo de HC.
☐ B. Una unidad de insulina por 10 gramos de HC.
☐ C. Una unidad por 100 gramos de HC.
☐ D. Diez gramos de proteína por unidad de insulina.

24. Para calcular la insulina que cubre los HC de una comida, ¿qué relación se utiliza?

☐ A. La relación insulina/carbohidratos
☐ B. La relación de calorías
☐ C. La cantidad de ejercicio
☐ D. La cantidad de grasas consumidas.

25. ¿Cuál puede ser una meta al contar carbohidratos con éxito?

☐ A. Bajar de peso rápidamente
☐ B. No comer en absoluto
☐ C. Consumir más carbohidratos
☐ D. Establecer una dosis óptima de insulina

26. En el sistema de raciones utilizado en este checklist, ¿a cuántos gramos de HC equivale una ración?

☐ A. 15 gramos
☐ B. 10 gramos
☐ C. 30 gramos
☐ D. 25 gramos

27. Si comes más HC de los previstos y usas una pauta ajustada por relación insulina/HC, ¿qué puede ocurrir?

☐ A. Puede aumentar la insulina necesaria para cubrir la comida, siguiendo tu pauta y considerando el resto de factores.
☐ B. Nunca cambia la necesidad de insulina.
☐ C. Siempre debes compensarlo con ejercicio intenso.
☐ D. Siempre debes omitir la siguiente comida.

28. ¿Qué afirmación es correcta sobre la relación insulina/HC?

☐ A. Debe ser idéntica para todas las personas.
☐ B. Cambia obligatoriamente solo por la estación del año.
☐ C. Se elige por los antojos de cada día.
☐ D. Puede variar según la hora y las circunstancias; se revisa con el equipo usando los patrones de glucosa.

29. ¿Qué es esencial al leer las etiquetas de productos para contar carbohidratos?

☐ A. La talla del paquete
☐ B. El contenido total de grasa
☐ C. La fecha de caducidad
☐ D. La cantidad de carbohidratos por porción o gramos

30. ¿Cuál es el objetivo principal de contar carbohidratos?

☐ A. Mejorar la variedad de la dieta
☐ B. Controlar los niveles de glucosa en sangre
☐ C. Reducir la cantidad de insulina diariamente
☐ D. Aumentar la ingesta de proteínas

31. Cuando el páncreas conserva su función, ¿qué hormona ayuda a regular la subida de glucosa tras comer?

☐ A. Insulina
☐ B. Glucosa
☐ C. Adrenalina
☐ D. Cortisol

32. ¿Qué riesgo se asocia a mantener glucosas elevadas después de las comidas de forma repetida?

☐ A. Desnutrición
☐ B. Hipoglucemia
☐ C. Incremento de peso
☐ D. Desarrollo de complicaciones

33. ¿Qué fuentes de HC conviene priorizar dentro de una alimentación equilibrada?

☐ A. Bebidas azucaradas como base de la dieta.
☐ B. Dulces sin considerar la cantidad.
☐ C. Legumbres, cereales integrales, fruta entera y otras fuentes con fibra y poco procesamiento.
☐ D. Alimentos refinados solo porque contienen almidón.

34. Si se ingieren más HC de los que cubre la dosis pautada, ¿qué puede ocurrir?

☐ A. Una bajada obligatoria de glucosa.
☐ B. Una subida de glucosa tras la comida.
☐ C. Pérdida de peso inmediata.
☐ D. Que deje de ser necesario medir la glucosa.

35. ¿Cuál es la función de la insulina de acción rápida?

☐ A. Cubrir por sí sola las necesidades basales de todo el día.
☐ B. Controlar exclusivamente el apetito.
☐ C. Eliminar la necesidad de calcular los HC.
☐ D. Ayudar a cubrir la subida de glucosa de la comida y/o corregir una glucosa elevada según la pauta.

36. ¿Cómo puede influir una comida rica en grasa en la respuesta de glucosa?

☐ A. Puede retrasar el vaciamiento del estómago y producir una subida más tardía de glucosa.
☐ B. Siempre acelera la digestión de todos los HC.
☐ C. Nunca tiene efecto.
☐ D. Hace innecesaria la insulina.

37. ¿Cuál es un ejemplo de alimento con HC y fibra que puede formar parte de una alimentación saludable?

☐ A. Azúcar de mesa.
☐ B. Lentejas cocidas.
☐ C. Refresco azucarado.
☐ D. Caramelos.

38. ¿Qué efecto puede tener la fibra de los alimentos sobre la respuesta de glucosa?

☐ A. Ayudar a moderar la absorción de HC y la subida de glucosa.
☐ B. Aumentarla siempre de forma inmediata.
☐ C. Garantizar pérdida de peso sin otros cambios.
☐ D. Sustituir por completo la insulina.

39. ¿Cuál es el objetivo al aprender a contar los carbohidratos?

☐ A. Eliminar todos los carbohidratos de la dieta
☐ B. Manejar la cantidad de insulina
☐ C. Mejorar el sabor de los alimentos
☐ D. Reducir las calorías consumidas

40. ¿Qué describe el índice glucémico (IG) de un alimento?

☐ A. Solo su contenido de fibra.
☐ B. Su cantidad de grasa.
☐ C. Los gramos totales de HC de cualquier porción.
☐ D. La respuesta de glucosa que produce frente a una referencia, comparando la misma cantidad de HC disponibles.

41. ¿Qué función cumple la insulina basal?

☐ A. Cubrir únicamente los HC de una comida.

☐ B. Sustituir siempre los bolos de una persona con diabetes tipo 1.

☐ C. Cubrir las necesidades de insulina entre comidas y durante la noche, con la frecuencia pautada para cada producto.

☐ D. Corregir de inmediato cualquier glucosa elevada.

42. ¿Cómo se decide el momento de administrar la insulina rápida de una comida?

☐ A. Siempre varias horas después, sin mirar la glucosa.

☐ B. Según el tipo de insulina, la glucosa, la comida y la pauta del equipo; habitualmente se administra antes de comer.

☐ C. Solo por la noche.

☐ D. No es necesario tener una pauta.

43. ¿Qué es el Ratio en el conteo de carbohidratos?

☐ A. Cuánto carbohidrato cubre una unidad de insulina

☐ B. Cuánto insulina se necesita para mantener el nivel de glucosa

☐ C. El número de calorías en una porción de alimento

☐ D. El porcentaje de grasa en la dieta

44. ¿Cuál de estos alimentos suele tener un índice glucémico bajo?

☐ A. Lentejas cocidas.

☐ B. Pan blanco.

☐ C. Glucosa pura.

☐ D. Cereales de maíz inflados.

45. ¿En qué consiste la terapia basal bolo?

☐ A. Uso exclusivo de insulina de acción prolongada

☐ B. Combinación de proteínas y carbohidratos

☐ C. Un solo tipo de insulina todos los días

☐ D. Combinación de insulina basal y de acción rápida

46. ¿Qué indica una glucosa elevada después de las comidas que se repite con frecuencia?

☐ A. Que conviene revisar los patrones y el plan, porque la hiperglucemia mantenida aumenta el riesgo de complicaciones.

☐ B. Que el tratamiento ya no necesita revisión.

☐ C. Que los controles no son necesarios.

☐ D. Que se deben eliminar todos los HC para siempre.

47. ¿Qué se debe hacer para ajustar la dosis de insulina?

☐ A. Registrar los niveles de glucosa antes y después de las comidas

☐ B. Modificar la cantidad de carbohidratos sin vigilancia

☐ C. Ignorar los carbohidratos por completo

☐ D. Aplicar insulina regularmente sin cambios

48. ¿Cómo puede ayudar conocer el índice glucémico, junto con la cantidad de HC y el resto de la comida?

☐ A. Puede ayudar a elegir alimentos y entender la respuesta de glucosa.

☐ B. Permite ignorar la cantidad que se come.

☐ C. Garantiza que nunca habrá una bajada.

☐ D. Permite eliminar la necesidad de insulina.

49. ¿Qué se compara para calcular el índice glucémico de un alimento?

☐ A. La cantidad de hierro del alimento.

☐ B. La respuesta de glucosa tras tomar la misma cantidad de HC disponibles del alimento y de una referencia.

☐ C. La cantidad de colesterol de la comida.

☐ D. La cantidad de proteínas exclusivamente.

50. ¿Puede aparecer glucosa en la orina cuando la glucosa en sangre está elevada?

☐ A. Toda la glucosa se convierte inmediatamente en grasa.

☐ B. No, nunca puede aparecer glucosa en la orina.

☐ C. Sí, cuando se supera la capacidad del riñón para reabsorberla; no ocurre igual ante cualquier subida.

☐ D. Toda la glucosa se convierte en proteínas.

51. En un ejemplo, si el IG es 50 y la porción tiene 20 g de HC disponibles, ¿cuál es su carga glucémica (IG × HC / 100)?

☐ A. 25

☐ B. 15

☐ C. 20

☐ D. 10

52. El factor de sensibilidad a la insulina (FSI) se utiliza para calcular:

☐ A. Los HC que se pueden comer sin límite.

☐ B. La proporción de insulina basal.

☐ C. El tiempo de acción de la insulina.

☐ D. La dosis de insulina correctora para una glucosa por encima del objetivo.

53. En un ejemplo educativo para una corrección, la glucosa actual es 290 mg/dl y el objetivo es 100 mg/dl. ¿Cuál es la diferencia?

☐ A. 250 mg/dl
☐ B. 220 mg/dl
☐ C. 180 mg/dl
☐ D. 190 mg/dl

54. La duración de la insulina activa se refiere a:

☐ A. Tiempo durante el cual la insulina ejerce su efecto
☐ B. Tiempo en que se inyecta la insulina
☐ C. Tiempo de espera antes de correr
☐ D. Tiempo que se necesita para calcular la dosis

55. El uso de calculadoras de bolus permite a los pacientes:

☐ A. Utilizar insulina de acción prolongada
☐ B. Aumentar la complejidad de su tratamiento
☐ C. Aquellos sin diabetes a controlar su ingesta
☐ D. Aumentar su independencia y autonomía en el control glucémico

56. Para muchos adultos no embarazados, ¿cuál es una referencia habitual de objetivo antes de comer, que debe individualizarse?

☐ A. 70-100 mg/dl para todo el mundo.
☐ B. 120-160 mg/dl obligatoriamente.
☐ C. 80-130 mg/dl, adaptándolo con el equipo.
☐ D. 200-250 mg/dl para todo el mundo.

57. ¿Qué debe hacerse antes de hacer un bolo corrector si se ha administrado insulina anteriormente?

☐ A. Repetir siempre el bolo al cabo de una hora.
☐ B. Aumentar siempre la corrección.
☐ C. Revisar cuánto bolo previo sigue activo y tenerlo en cuenta según el calculador o el plan pautado.
☐ D. Administrar otra dosis sin comprobar nada.

58. ¿Qué objetivo de glucosa debe utilizarse para calcular una corrección?

☐ A. El acordado con el equipo para esa persona y momento.
☐ B. Siempre 80 mg/dl para cualquier persona.
☐ C. Siempre 100 mg/dl para todo el mundo.
☐ D. El que permita obtener la dosis más alta.

59. ¿Qué puede ocurrir con la glucosa tras una comida con bastante grasa?

☐ A. Siempre baja sin necesidad de insulina.

☐ B. Puede producirse una subida más tardía y prolongada; se revisan los patrones con el equipo.

☐ C. Siempre sube solo durante los primeros 5 minutos.

☐ D. Nunca cambia.

60. ¿Qué debes considerar antes de repetir un bolo corrector?

☐ A. Que siempre debe repetirse a la hora.

☐ B. Que siempre se puede repetir sin mirar la glucosa.

☐ C. La insulina que sigue activa, el tipo de insulina y la pauta acordada; no existe una regla universal de repetir a las 2 horas.

☐ D. Que una segunda dosis no puede causar hipoglucemia.

61. ¿Qué nutriente se transforma en glucosa en mayor cantidad cuando se ingiere?

☐ A. Hidratos de carbonos

☐ B. Grasas

☐ C. Proteínas

☐ D. Fibras

62. ¿Cuál es la conclusión final sobre el ajuste de la dosis para la cobertura de la ingesta?

☐ A. Reduce la calidad de vida

☐ B. Incrementa las fluctuaciones de glucosa

☐ C. Permite un mejor control de la diabetes

☐ D. No tiene relación con los objetivos de glucosa

63. Si se expresa en gramos de HC por unidad, ¿qué representa la relación insulina/HC?

☐ A. La dosis total diaria de insulina.

☐ B. Cuántos gramos de HC cubre aproximadamente una unidad de insulina rápida.

☐ C. La cantidad de agua que se debe beber.

☐ D. Un sistema para clasificar las insulinas basales.

64. ¿Cuál es la importancia del recuento de carbohidratos para personas con diabetes de tipo 1?

☐ A. Ayuda a administrar la insulina de manera efectiva en función de la cantidad de carbohidratos consumidos.

☐ B. Permite planificar una dieta sin restricciones.

☐ C. Es un método para aumentar el consumo de carbohidratos.

☐ D. Facilita la identificación de alimentos prohibidos.

65. ¿Qué factores pueden hacer necesario revisar la relación insulina/HC con el equipo?

☐ A. Solo el día del mes.

☐ B. Únicamente el color de la pluma.

☐ C. Solo el precio de los alimentos.

☐ D. Los patrones de glucosa, la hora, la actividad, los cambios de sensibilidad y las circunstancias personales.

66. En un ejemplo teórico, si 1 unidad cubre 10 g de HC, ¿cuántas unidades cubrirían 45 g, sin corrección ni insulina rápida previa activa?

☐ A. 3 unidades.

☐ B. 5 unidades.

☐ C. 4,5 unidades.

☐ D. 6 unidades.

67. ¿Qué expresa el factor de sensibilidad o de corrección de la insulina?

☐ A. Los HC que se pueden comer sin insulina.

☐ B. El tiempo que se tarda en comer.

☐ C. Cuántos mg/dl se estima que baja la glucosa con una unidad de insulina rápida.

☐ D. La cantidad de alimentos que se deben evitar.

68. ¿Cuál es la relación general entre el momento del día y los ratios de insulina/carbohidratos?

☐ A. Puede variar según la hora y la persona; no hay un patrón único para todo el mundo.

☐ B. Siempre es mayor por la tarde para todas las personas.

☐ C. Debe mantenerse igual aunque cambien los patrones de glucosa.

☐ D. Solo depende del nombre de la comida.

69. Durante o después del ejercicio, ¿cómo pueden cambiar las necesidades de insulina?

☐ A. Siempre aumentan y se debe subir la dosis sin comprobar nada.

☐ B. Pueden disminuir, pero dependen del ejercicio, la glucosa y la insulina activa; se sigue el plan individual.

☐ C. Se debe suspender toda la insulina basal.

☐ D. Nunca cambian.

70. En un ejemplo, 3 unidades cubren 45 g de HC. ¿Cuál es la relación expresada en gramos de HC por unidad?

☐ A. 5 g por unidad (1:5).

☐ B. 30 g por unidad (1:30).

☐ C. 15 g por unidad (1:15).

☐ D. 45 g por unidad (1:45).

Plantilla de respuestas

Para uso del profesional. Cada letra identifica la única opción correcta de la versión online y de este PDF.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	D	C	D	B	D	C	C	B
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	C	D	C	B	B	C	C	A	A
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
B	D	B	A	D	B	A	D	D	B
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
A	D	C	B	D	A	B	A	B	D
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
C	B	A	A	D	A	A	A	B	C
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
D	D	D	A	D	C	C	A	B	C
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
A	C	B	A	D	C	C	A	B	C

Puntuación: aciertos ÷ 70 × 100. Aprueba con 49/70 o más. No redondees el porcentaje antes de decidir el aprobado.

Registro en historia clínica

Checklist: Conteo de hidratos de carbono (HC). Resultado: APRUEBA / NO APRUEBA. Puntuación: ___/70 aciertos (___ %). Incorrectas: ___. Sin responder: ___. Fecha: ___. Versión: 2026-10-12.1.

Adaptación de los cuestionarios aportados para ENDONUTRI. El criterio del 70 % es el establecido para su uso en consulta; no convierte estos checklists en una escala clínica validada. El original se conserva por separado.

Fuentes de la revisión

ADA 2026: Educación y actividad física · Objetivos e hipoglucemia · Riesgo cardiovascular

AEMPS: Tresiba · NovoRapid · Glucagón nasal

Técnica de inyección: FITTER Forward 2025

UCSF Diabetes Teaching Center: HC y cálculo de insulina · Insulina activa e hipoglucemia

Otras fuentes: ESC 2023 · Índice glucémico (Sídney) · Preguntas sobre IG · Lentejas · SAEDYN 2021